

Ansiedad de Separación y Fobias Escolares

1. Introducción y relevancia clínica

La **ansiedad de separación** y las **fobias escolares** son dos de los **trastornos de ansiedad más comunes en la infancia**, caracterizados por un miedo o angustia excesiva frente a la separación de figuras de apego (generalmente los padres) o ante la asistencia a la escuela.

Son **cuadros frecuentes en atención primaria**, con prevalencias estimadas de:

- **Ansiedad de separación:** 3–5% de los niños.
- **Fobia escolar:** 1–2%, más común entre los 6 y 12 años.

Si bien cierto grado de ansiedad es **normal y evolutivo** (por ejemplo, el miedo a separarse de los padres entre los 8 meses y los 3 años), cuando los síntomas son **desproporcionados, persistentes y afectan el funcionamiento diario**, se configura un **trastorno clínico**.

□ En EUNACOM, suelen presentarse preguntas donde un niño rechaza ir al colegio, presenta síntomas físicos (dolor abdominal, vómitos) o llanto intenso al separarse de los padres. El desafío está en diferenciar si se trata de un proceso adaptativo o un trastorno de ansiedad de separación/fobia escolar.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Bases neurobiológicas

Los trastornos de ansiedad infantil comparten alteraciones funcionales en:

- **Amígdala y sistema límbico**, responsables del procesamiento del miedo.
- **Corteza prefrontal medial**, que regula las respuestas emocionales.
- Disminución del **GABA** e hiperactividad del **sistema serotoninérgico y noradrenérgico**, generando respuestas de hipervigilancia y alerta sostenida.

2.2. Factores genéticos y temperamentales

- Hijo de padres con **trastornos de ansiedad o depresión** → riesgo aumentado 3–5 veces.
- Niños con temperamento **inhibido, tímido o dependiente**.
- Mayor vulnerabilidad en familias con sobreprotección o escasa tolerancia a la frustración.

2.3. Factores ambientales y psicológicos

- **Eventos estresantes recientes:** cambio de escuela, separación de los padres, enfermedad familiar.
- **Modelamiento parental:** padres ansiosos o controladores refuerzan la ansiedad infantil.
- **Refuerzos secundarios:** el niño aprende que al manifestar ansiedad (llanto, quejas somáticas) puede evitar situaciones que le generan temor.

□ Conceptualmente, se trata de **un miedo irracional mantenido por evitación**, donde la conducta de los cuidadores (tranquilizar o permitir la evasión escolar) perpetúa el ciclo ansioso.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Trastorno de Ansiedad por Separación (TAS)

Definición (DSM-5):

Ansiedad excesiva e inapropiada para la edad, relacionada con la separación de figuras de apego, que persiste por **≥4 semanas** (en niños) y causa malestar o deterioro significativo.

Síntomas principales:

Debe cumplirse al menos **3 de los siguientes**:

1. Malestar excesivo al anticipar o experimentar la separación.
2. Preocupación persistente por perder o dañar a la figura de apego.
3. Miedo a que ocurra un evento catastrófico (accidente, secuestro).
4. Rechazo persistente a ir a la escuela o lugares sin el cuidador.

5. Dificultad para dormir sin la presencia o cercanía del cuidador.
6. Pesadillas recurrentes con temas de separación.
7. Síntomas físicos (cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal) en anticipación a la separación.

Edad de inicio típica:

- Entre **6 y 9 años**, a menudo tras un evento estresante.
 - Puede ser más leve en preescolares y más disruptivo en escolares.
-

3.2. Fobia escolar

No constituye un diagnóstico independiente, sino una **manifestación conductual del TAS o de otros trastornos de ansiedad**.

Se define como **miedo intenso y persistente a asistir al colegio**, que lleva al **rechazo escolar o ausentismo prolongado**.

Características:

- El niño puede llorar, suplicar o manifestar síntomas somáticos al intentar ir al colegio.
- La ansiedad desaparece durante los fines de semana o vacaciones.
- No hay un problema de disciplina o rebeldía (como en el TDO).
- La relación con los padres suele ser de apego ansioso o sobreprotector.

☐ En la práctica chilena, se utiliza el término “**rechazo escolar ansioso**” como equivalente a fobia escolar.

3.3. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico

Características diferenciales

TDAH o TDO	Negativa a asistir al colegio por rebeldía o impulsividad, sin ansiedad ni síntomas físicos.
Bullying o maltrato escolar	Miedo justificado a asistir al colegio por agresión real o acoso.
Depresión infantil	Rechazo escolar por anhedonia o falta de motivación, no por miedo.
Fobia específica	Ansiedad focalizada (p. ej., miedo a animales o oscuridad), sin relación con la separación.
Trastorno del espectro autista	Evitación social generalizada, no dependiente de figuras de apego.

☐ Es fundamental **descartar causas externas reales**, como acoso o violencia, antes de etiquetar el cuadro como ansioso.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico es **clínico** y se basa en:

- **Anamnesis detallada** con padres y niño.
- **Historia del desarrollo emocional.**
- **Temporalidad y persistencia de los síntomas.**
- **Impacto funcional** (rendimiento escolar, sueño, vida familiar).

4.2. Herramientas de evaluación

- **Escala de Ansiedad Infantil de Spence (SCAS).**
- **Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED).**

- **Escala de Ansiedad por Separación de MASC o CBCL.**

En Chile, las **guías MINSAL de salud mental infanto-juvenil** recomiendan usar instrumentos de pesquisa complementarios al juicio clínico, especialmente en APS o COSAM.

4.3. Exámenes complementarios físicos

Solo se solicitan si hay síntomas somáticos persistentes para descartar causas orgánicas (por ejemplo, vómitos recurrentes o cefalea).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento debe ser **integral, gradual y coordinado entre familia, escuela y salud**, priorizando la **intervención psicológica y psicoeducativa**.

5.1. Intervenciones psicoeducativas y psicoterapéuticas

1. Psicoeducación familiar

- Explicar que el miedo es irracional y autoperpetuado por la evitación.
- Reforzar el **rol de los padres en mantener límites firmes** pero empáticos.
- Evitar reforzadores negativos: no permitir quedarse en casa “por sentirse mal”.
- Promover autonomía y exposición progresiva.

2. Terapia cognitivo-conductual (TCC)

Es la **primera línea de tratamiento**, con alto nivel de evidencia (1A).

Incluye:

- **Psicoeducación sobre la ansiedad.**
- **Entrenamiento en relajación y respiración.**
- **Reestructuración cognitiva** (identificar pensamientos catastróficos).
- **Exposición gradual en vivo** a la separación o asistencia escolar.
- **Refuerzo positivo** tras logros parciales.

3. Intervención escolar

- Coordinación con docentes y orientadores.
 - **Reintegración progresiva:** horarios parciales al inicio, actividades agradables.
 - Promover clima de seguridad emocional en el aula.
-

5.2. Tratamiento farmacológico

Indicaciones:

- Cuando el cuadro es **moderado a severo**, con **resistencia a psicoterapia** o comorbilidad ansioso-depresiva.
- Bajo supervisión de **psiquiatra infantil**.

Fármacos utilizados:

Grupo	Fármaco	Comentarios
ISRS	Sertralina, fluoxetina	Primera elección; iniciar dosis bajas. Efecto en 4–6 semanas.
Ansiolíticos (benzodiacepinas)	Clonazepam (uso breve)	Solo en crisis agudas y por períodos cortos. Evitar dependencia.
Alternativos	Buspirona	En casos leves o intermedios.

□ En Chile, las guías MINSAL establecen los **ISRS** como tratamiento farmacológico de elección para los trastornos de ansiedad infantil, siempre acompañado de psicoterapia.

5.3. Rol del equipo de salud

- **APS:** detección, contención familiar, derivación a COSAM.
- **COSAM:** diagnóstico especializado, psicoterapia, seguimiento.

- **Escuela:** reintegración progresiva y apoyo emocional.
 - **Familia:** mantener límites y participación activa.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones

- Cronificación del cuadro ansioso.
- Desarrollo de otros trastornos de ansiedad o depresión.
- Dificultades académicas y de socialización.
- Dependencia emocional prolongada de los padres.

6.2. Pronóstico

- En general **favorable** con intervención temprana.
- El **inicio temprano de tratamiento TCC** reduce riesgo de recaídas.
- Sin intervención, puede evolucionar hacia **trastorno de pánico o agorafobia** en la adolescencia.

Factores de buen pronóstico:

- Diagnóstico precoz (<10 años).
- Apoyo familiar consistente.
- Ausencia de comorbilidades psiquiátricas.
- Colaboración del entorno escolar.

☐ Con manejo adecuado, más del **80% de los niños mejora o remite en 6–12 meses.**

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. La **ansiedad de separación** es normal hasta los 3 años; después de esa edad, se considera patológica si interfiere con la vida cotidiana.
 2. La **fobia escolar** es una manifestación del TAS, no una falta de disciplina.
 3. El **diagnóstico es clínico**, no requiere exámenes ni neuroimágenes.
 4. La **psicoterapia cognitivo-conductual** es el pilar del tratamiento.
 5. Los **ISRS** (fluoxetina o sertralina) se usan solo si hay resistencia o severidad.
 6. Es crucial **coordinar salud, familia y escuela** para evitar cronificación.
 7. La **evitación reforzada** (dejar que el niño no asista al colegio) perpetúa el cuadro.
-



Errores comunes

- Confundir ansiedad de separación con “mañas” o rebeldía.
 - Permitir ausentismo escolar prolongado.
 - Iniciar medicación sin psicoterapia previa.
 - No descartar causas externas (acoso, abuso, bullying).
 - No involucrar a la escuela en el proceso terapéutico.
 - Suspender ISRS abruptamente.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **ansiedad de separación** es un trastorno del neurodesarrollo emocional caracterizado por miedo excesivo e irracional a separarse de los padres.

2. La **fobia escolar** es su manifestación conductual más frecuente en edad escolar.
3. El diagnóstico es **clínico**, basado en persistencia, intensidad y disfunción.
4. El tratamiento de elección es la **Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)** y **psicoeducación familiar**.
5. Los **ISRS** son una opción de segunda línea en casos moderados o graves.
6. La **colaboración entre familia, escuela y salud** es esencial para la recuperación.
7. La **detección y reintegración temprana al colegio** mejoran notablemente el pronóstico.